

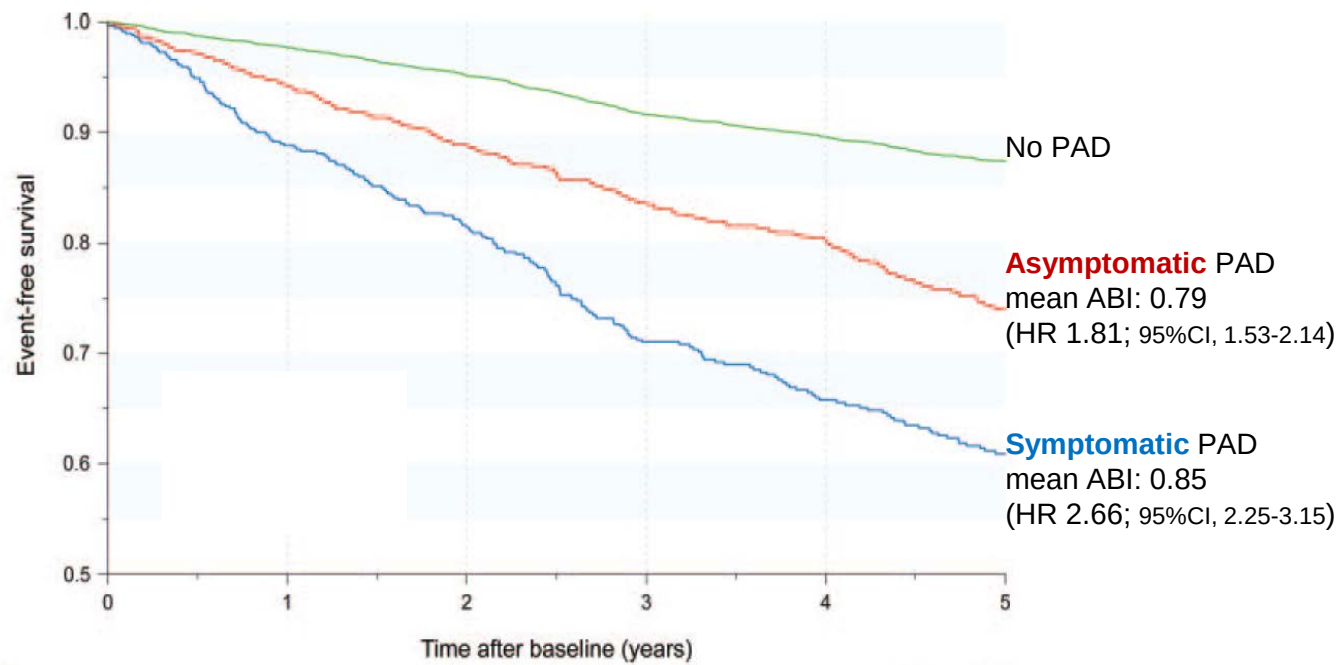
Répétitoire examens fédéraux 2019

Angiologie
Andreas Erdmann

QCM 1

Typ A (1 réponse)

- Laquelle de ces affirmations concernant l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est correcte?
 - ☒ A. Les patients avec AOMI asymptomatique ont une espérance de vie diminuée
 - ☐ B. Il y a un haut risque d'amputation chez les patients avec AOMI
 - ☐ C. L'AOMI augmente de 5% le risque de mortalité à 5 ans
 - ☐ D. La majorité des patients avec AOMI auront un geste de revascularisation au cours de leur vie
 - ☐ E. Aucune



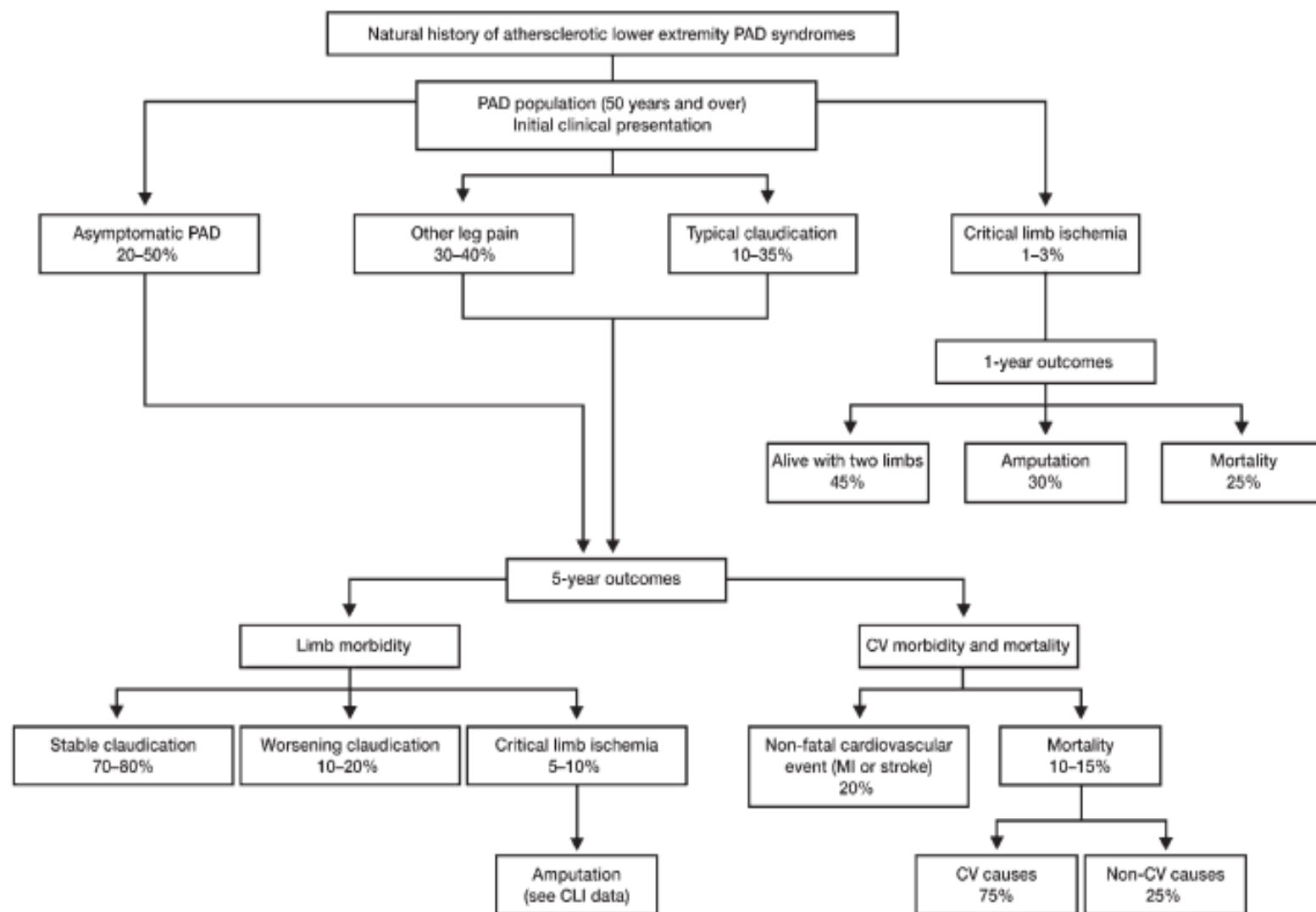


Fig. A3. Fate of the claudicant over 5 years (adapted from ACC/AHA guidelines⁵). PAD – peripheral arterial disease; CLI – critical limb ischemia; CV – cardiovascular; MI – myocardial infarction. Adapted with permission from Hirsch AT *et al. J Am Coll Cardiol* 2006;**47**:1239–1312.

QCM 2

- Laquelle de ces affirmations concernant l'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) est correcte?
 - A. La majorité des AAA se trouve en position infra-rénale
 - B. L'AAA infra-rénale typiquement ne s'élargit pas avec l'âge
 - C. Le diamètre moyen d'une AAA chez les hommes est < 3 cm
 - D. Environ 60% des patients avec une AAA ont une anamnèse familiale positive

AAA

- Anévrisme: dilatation permanente, localisée, d'un segment artériel >50% par rapport aux segments adjacents
- Pour l'aorte abdominale: diamètre $\geq 3\text{cm}$
- >90% des AAA sont en position infra-rénale
- Diabète: facteur protectif
- Une histoire familiale positive est présente chez certains patients (OR entre 1.9 et 6) mais pas chez la majorité
 - Tabagisme et âge sont les FR les plus importants

QCM 3

- **Vous voyez en contrôle un patient asymptomatique, ancien fumeur, de 67 ans avec anévrisme de l'aorte abdominale de 47 mm vs 37 mm l'an passé. Quelle attitude adoptez vous ?**
 1. Contrôle rapproché dans 6 mois
 2. Maintien d'un contrôle annuel
 - ☒ 3. Demande d'un avis chirurgical
 4. Contrôle rapproché dans 3 mois

QCM 4

- Laquelle de ces affirmations concernant l'exercice physique pour le traitement de la claudication intermittente **n'est pas correcte** ?
 - A. Les programmes de réhabilitation vasculaire devraient durer 6 mois avant d'en établir leur efficacité
 - B. L'exercice devrait être supervisé par un maître de sport ou physiothérapeute
 - C. Le programme devrait inclure au moins 3 séances/semaine
 - D. Le type d'exercice effectué est essentiellement de la marche

QCM 5

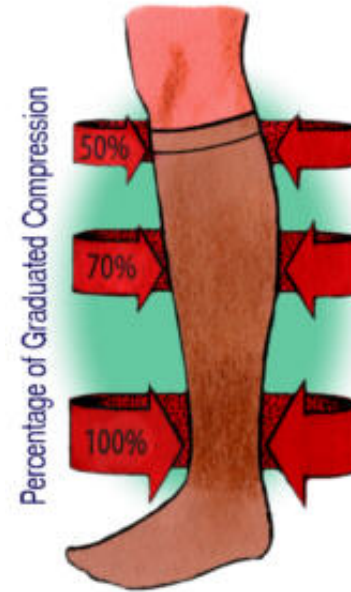
- Concernant le syndrome post thrombotique (SPT) laquelle de ces affirmations est **fausse** ?
 - A. Le SPT est caractérisé par un œdème chronique et lourdeur
 - B. Dans le stade avancé le SPT se caractérise par l'apparition d'une hyperpigmentation cutanée, et des veines variqueuses
 - ☒ C. Le SPT est une complication rare de la TVP
 - D. Après un épisode de TVP proximale l'incidence de SPT est d'environ 50%

Syndrome post thrombotique

- Le syndrome post-thrombotique (SPT) représente la complication la plus fréquente d'une thrombose veineuse profonde (TVP)
- La prévalence est d'environ **30-50%**, la plupart des SPT surviennent dans les **2 ans suivant** l'épisode de TVP
- Il s'agit d'une insuffisance veineuse survenue chez un patient ayant présenté une TVP
- Dans les études avec suivi prolongé: le taux d'ulcères veineux augmente dans le temps avec une incidence de **5% à 10 ans**

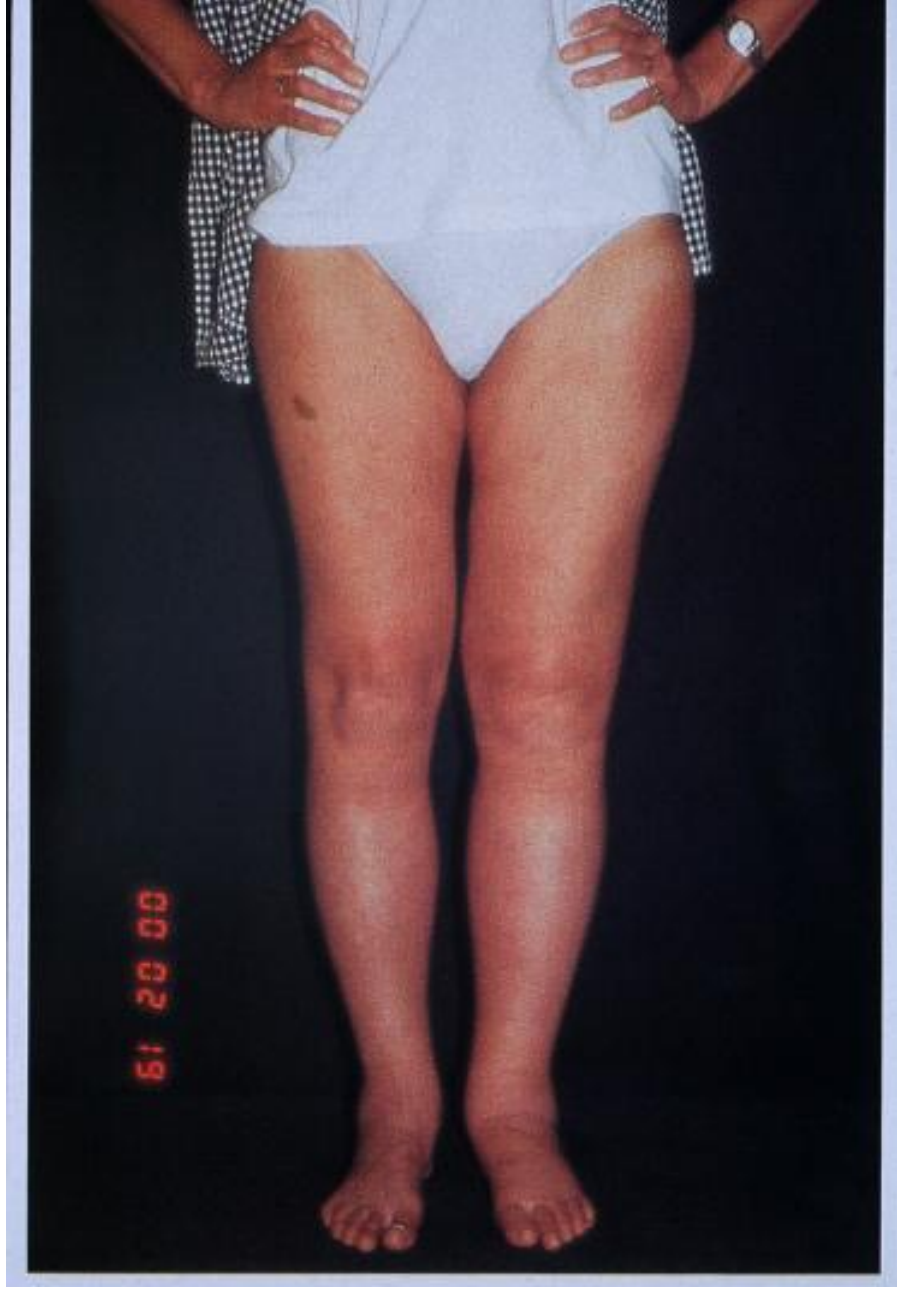
Compression élastique

- Réduit l'extravasation d'origine veineuse
- Augmente le retour sanguin
- Améliore la microcirculation cutanée et le flux lymphatique
- La pression doit être adaptée à la sévérité du SPT



QCM 6

- Une femme de 29 ans, photographe du National Geographic , consulte votre cabinet. Elle a commencé à travailler à l'âge de 23 ans et elle consulte en raison d'un œdème du MIG apparu autour de 15 ans. Il y a aussi un œdème au niveau du pied et des orteils. Quelle condition est plus susceptible de se présenter avec ce tableau clinique ?
 - A. Lymphoedème précoce
 - B. Lymphoedème tardif
 - C. Insuffisance veineuse chronique
 - D. Filariasis



Le signe du pli cutané (signe de Stemmer)



Lymphoedème

Lymphoedème primaire:

- congénital (< 2ans)
- précoce < 25 ans (extrêmes 12-35 ans, typiquement autour de la puberté)
- tardif > 35 ans

Lymphoedème secondaire:

apparaît **vers 50 ans**

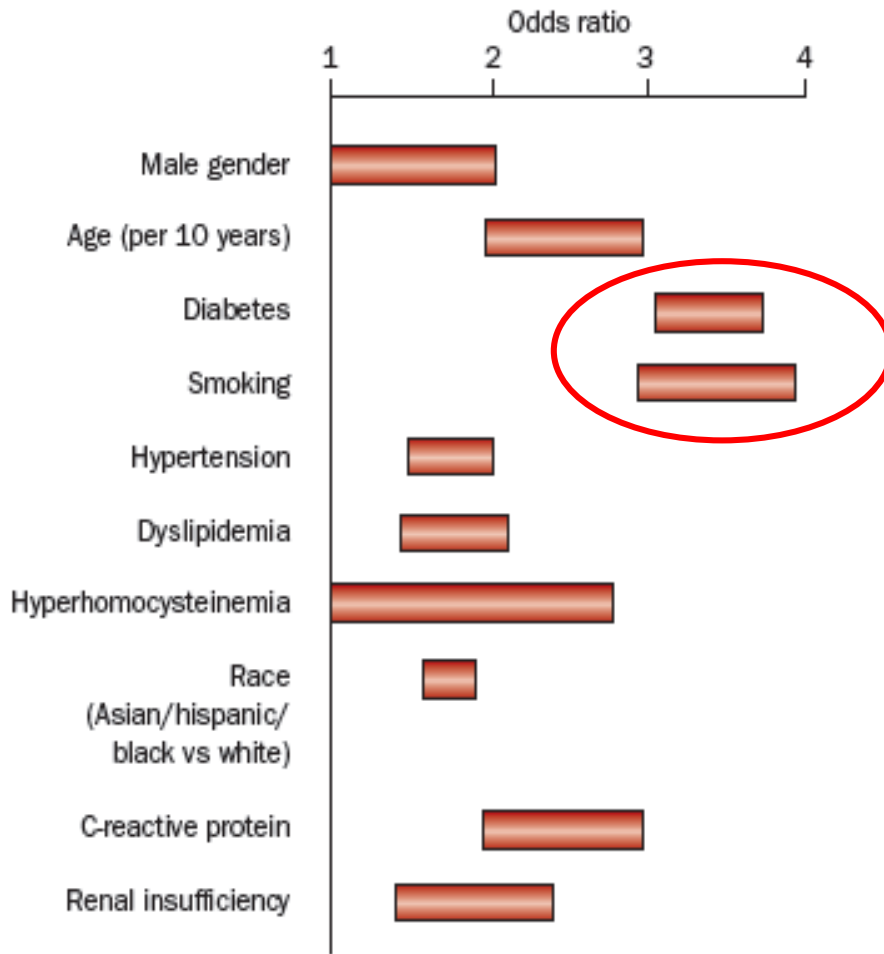
- tumeur : utérus (59%), prostate (15%)
- chirurgie + radiothérapie
- traumatisme (fracture du membre inférieur) (10%)

Filariasis peu probable, le LO a démarré avant les voyages

QCM 7

- Quels sont les facteurs de risque les plus importants pour l'artériopathie périphérique ?
 - A. Sexe masculin et hypertension systolique
 - B. Hypertension systolique et diastolique
 - ☒ C. Tabagisme et diabète
 - D. LDL élevés et HDL diminués
 - E. Cholestérol total élevé et insuffisance rénale

Facteurs de risque pour l'AOMI



- Les fumeurs développent des symptômes d'AOMI 10 ans avant les non fumeurs
- Les patients fumeurs avec AOMI ont un risque significativement augmenté de voir leur maladie progresser vers une ischémie critique
- Les patients avec AOMI traités par pontage qui continuent de fumer ont un risque augmenté (3x) d'occlusion du pontage
- L'arrêt du tabagisme est efficace dans la diminution de la progression de l'AOMI

QCM 8

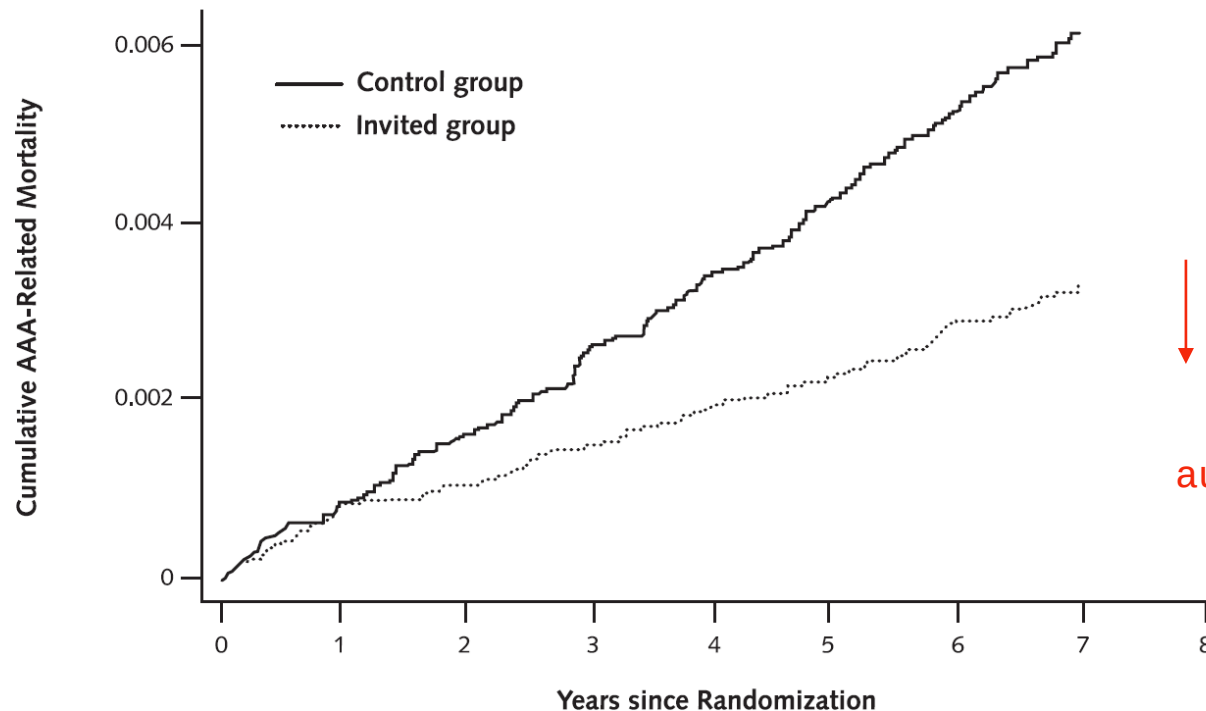
- Chez quel type de patient un dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) a montré une diminution de la mortalité lié à l'AAA?
 - A. Homme 65-74 ans tabagique
 - B. Homme 55-64 ans tabagique
 - C. Femme 55-64 tabagique
 - D. Femme 55-65 diabétique

Quelle population devrait être dépistée ?

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Population screening for AAA with ultrasound.		
is recommended in all men >65 years of age.	I	A
may be considered in women >65 years of age with history of current/past smoking.	IIb	C
is not recommended in female non-smokers without familial history.	III	C
Targeted screening for AAA with ultrasound should be considered in first-degree siblings of a patient with AAA.	IIa	B

Mortalité liée à l'AAA

Suivi à 7 ans



↓ 53% taux de décès
pour ceux
qui ont participé
au dépistage (hommes
65-74 ans)

Men at risk, *n*

Control group	33 887	33 046	32 100	31 049	29 979	28 850	27 630	15 456
Invited group	33 883	33 016	32 073	31 117	30 094	28 992	27 828	15 634

QCM 9

Une femme de 23 ans consulte son médecin de famille. Elle présente depuis 3 jours des douleurs du mollet gauche. Les douleurs sont exacerbées à la marche, s'accompagnent d'un œdème et d'un état de fatigue.

L'anamnèse familiale et personnelle est sans particularité, exception faite d'une activité sportive intense il y a 1 semaine.

La patiente est sous contraception orale depuis 4 mois.

Au status, une augmentation de 2 cm du périmètre du mollet gauche est mise en évidence

Quelle est votre première attitude ?

- A. Ultrasonographie des membres inférieurs
- B. Contention élastique et nouveau contrôle clinique dans 7 jours
- C. Démarrer une anticoagulation par héparine à bas poids moléculaire
- D. CT-scan des membres inférieurs
- ☒ E. Dosage D-dimères

TVP-EP: probabilité clinique (Score de Wells)

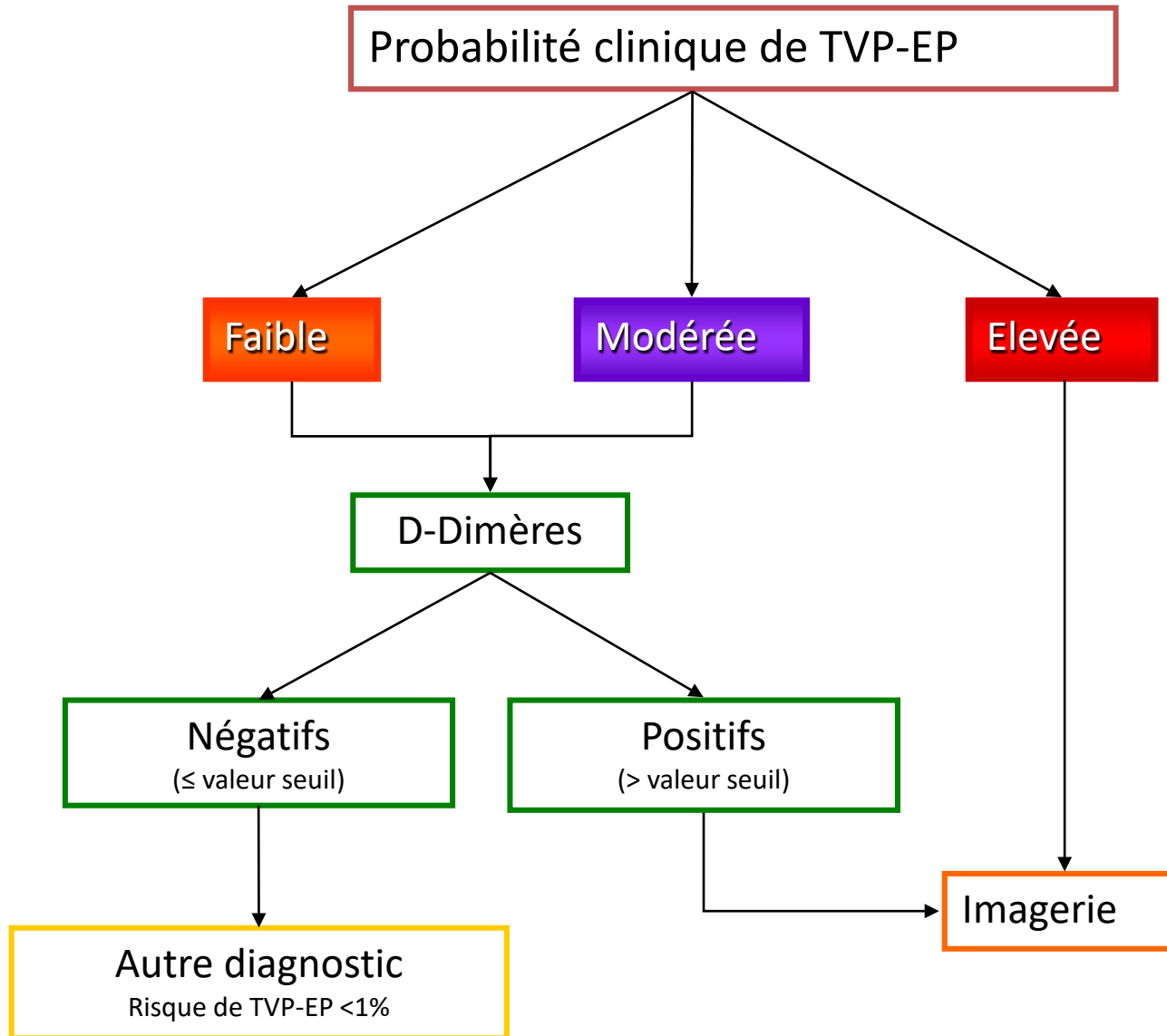
– cancer évolutif : <i>traitement en cours ou récent (< 6 mois)</i>	+1
– paralysie, parésie ou plâtre récente des Mb Inf	+1
– alitement récent > 3 j ou chirurgie majeure récente (< 12 semaines)	+1
– douleur provoquée localisée à la palpation des axes veineux	+1
– augmentation du diamètre de tout le Mb Inf	+1
– augmentation du diamètre > 3cm du mollet	+1
– collatéralité de suppléance par veines superficielles non variqueuses	+1
– diagnostic alternatif <i>au moins aussi</i> vraisemblable que la TVP	-2

0 = probabilité faible

1-2 = probabilité modérée

≥3 = probabilité élevée

TVP-EP: algorithme décisionnel

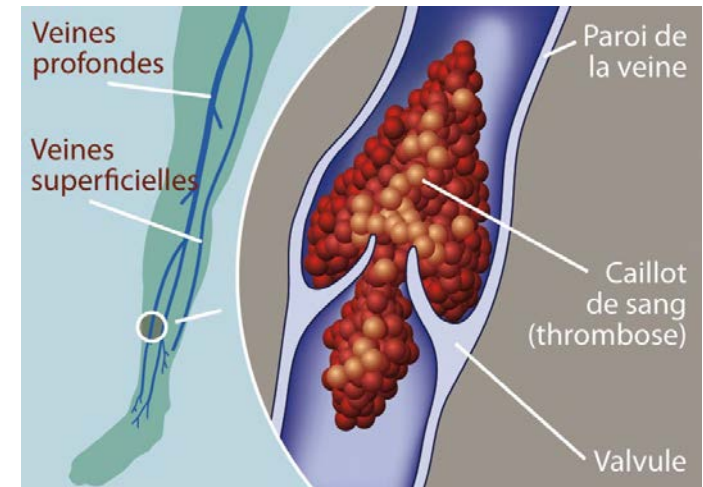


QCM 10

- Concernant l'histoire naturelle et la physiopathologie de la thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs laquelle de ces affirmations est **fausse** ?
 - A. Les TVP distales représentent environ le 20 % de toutes les TVP des membres inférieurs
 - ☒ B. Sans traitement, une TVP distale s'étend en proximale dans 60% des cas
 - C. Non traitée, une TVP proximale est associée à 50% de risque d'EP symptomatique à 3 mois
 - D. Le thrombus apparait dans un nid valvulaire puis s'étend

Pronostic de la MTEV symptomatique non traitée

- TVP distale isolée:
 - ✓ $\pm$ 33% extension proximale
- TVP proximale:
 - ✓ $\pm$ 50% EP symptomatique à 3 mois
- EP:
 - ✓ 26% récurrence fatale d'EP dans délai de 2 semaines
 - ✓ 26% récurrence non fatale d'EP



QCM 11

- **Laquelle des affirmations suivantes concernant l'index cheville/bras (ankle /brachial index, ABI) est fausse ?**
 1. Un ABI < 0.9 est hautement sensible et spécifique en faveur d'une artériopathie oblitérante des MI
 2. Un ABI < 0.9 est hautement sensible et spécifique pour la présence de sténose artérielle d'au moins 50%, vérifiée par angiographie.
 3. Un ABI dans la norme est hautement sensible et spécifique pour exclure une artériopathie oblitérante des MI
 4. Une diminution de l'ABI de 20% lors de test d'effort est significative et en faveur d'une artériopathie oblitérante
 5. Un ABI > 1.4 est un faveur d'un augmentation de la mortalité cardio-vasculaire

QCM 12

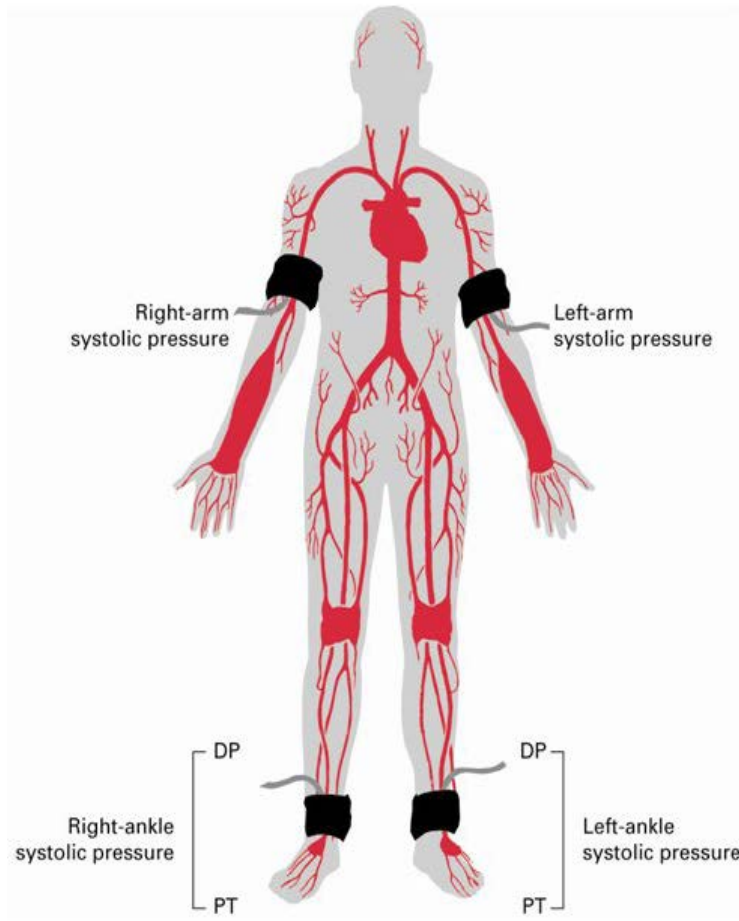
- Un Ankle Brachial Index (ABI) supérieur à 1.4 témoigne:
 - A. Artères rigides, non compliantes
 - B. Diagnostic de diabète
 - C. Circulation artérielle normale
 - D. Hypertension

Interprétation de l'ABI

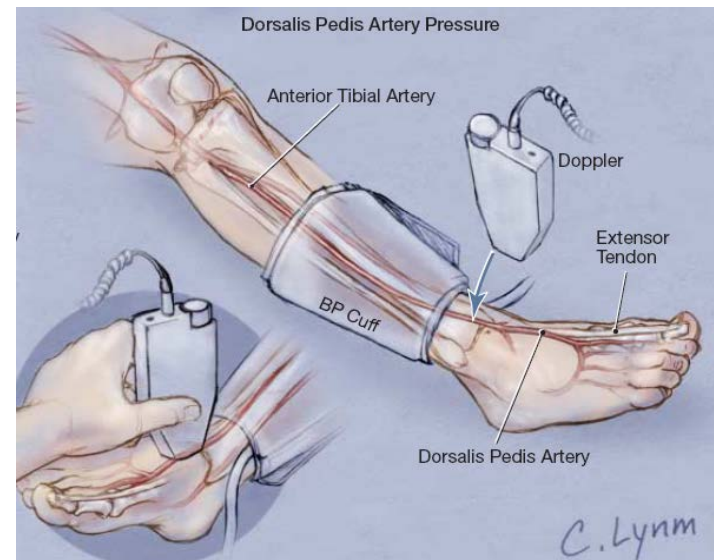
ABI	Interprétation
0.91 -1.30	normal
0.70 - 0.90	faible
0.40 - 0.69	modéré
≤ 0.40	grave
> 1.40	médiacalcose

ABI ≤ 0.9 est sensible et spécifique jusqu'à 95% pour une maladie artérielle/AOMI constatée par angiographie

Le dépistage de l'AOMI avec la mesure de l'ABI (Ankle Brachial Index)



	Sensibilité (%)	Spécificité (%)
Questionnaire	66	98
Ex. physique	48-90	70-86
ABI <0.9	>90	95



Mesure de pressions à la cheville

QCM 13

- Un patient de 78 ans avec cancer du colon métastatique développe une thrombose veineuse profonde (TVP) de la veine fémorale superficielle droite. Il a été mis sous traitement par héparine à bas poids moléculaire pendant les derniers 5 jours. Il développe soudainement une nécrose du gros orteil D.

Quel test faites-vous pour comprendre l'origine de cette nécrose ?

- A. Echo cœur à la recherche d'une source emboligène cardiaque
- B. Un CT- abdomen à la recherche d'une source emboligène artérielle
- ☒ C. Compte plaquettaire
- D. Rien: le diagnostic est clairement une nécrose cutanée induite par l'héparine

	Fondaparinux	Antagonistes de Vit K	Héparines	
			HNF	HBPM
Liaisons non spécifiques aux prot	Non	+++++	+++	++
Dose pour le traitement	1/jour s.c.	Selon INR p.o.	Selon aPTT i.v.	1 ou 2/jour s.c.
Monitoring	non	INR	aPTT Plaquettes	Plaquettes
Variabilité inter/ intra individuelle	+	+++++	+++	++
Utilisation en cas d'insuffisance rénale sévère	Non	Oui	Oui	Attention!
Utilisation en cas d'insuffisance hépatique modérée	Oui	Attention!	Oui	Oui
Cross réactivité en cas de HIT et liaison au PF4	Non	Non	++	+

Question 14

Patiente hypertendue de 32 ans, avec une baisse de l'état général, se présente en angiologie en raison de la mise en évidence d'une différence de 25 mmHg entre les 2 pressions humérales. Elle se plaint d'arthralgies et décrit un phénomène de Raynaud à certains doigts. A l'examen clinique, absence de pouls radial droit.

Quelle(s) affection(s) peut (peuvent) donner lieu à un tel tableau clinique?

- A. Un vol vertébral
- B. Un syndrome du défilé thoraco-brachial
- C. Une ischémie aiguë d'origine cardiaque
- D. Une maladie professionnelle
- ☒ E. Une maladie de Takayasu

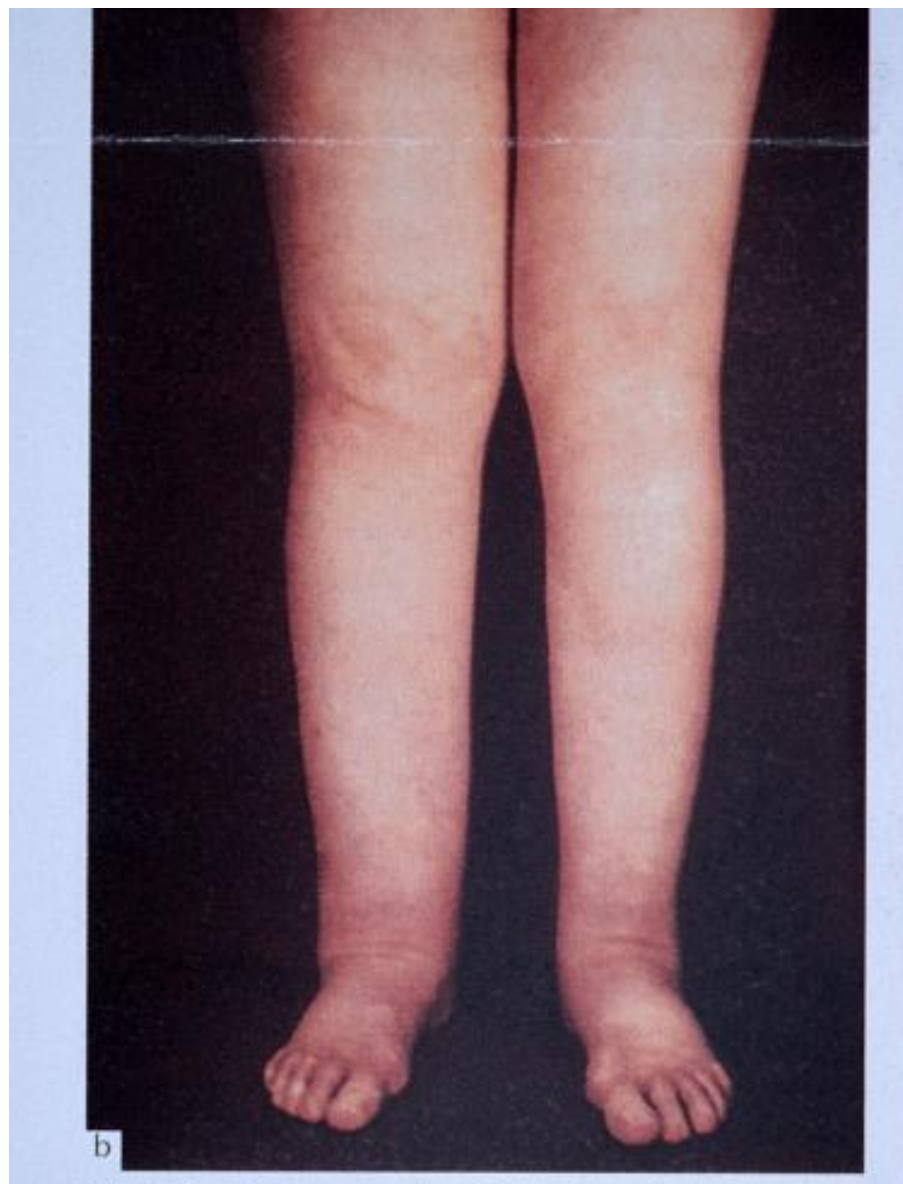
Maladie de Takayasu

- Se manifeste chez la femme jeune dans 80% des cas
- HTA dans 40-70% (sténose des artères rénales), souffles artériels, syndromes neurovasculaires (TIA), symptômes oculaires, absence de pouls et/ou claudication des MS, circulation collatérale au niveau des épaules et de la poitrine, fièvre, fatigue
- **phase préocclusive** : symptômes généraux (fièvre, fatigue, arthralgies/myalgies, érythème noueux, pyoderma gangrenosum, uvéite, épisclérite)
- **phase occlusive**: symptômes liés aux sténoses, occlusions et anévrismes (claudication, ischémie, infarctus, ...)
- Pronostic: survie à 5 ans entre 80 et 97%

QCM 15 (type A = 1 réponse)

Une patiente de 64 ans avec un cancer de l'endomètre consulte pour un œdème indolore des membres inférieurs. L'œdème est apparu progressivement depuis 12 mois et est présent depuis le matin.

A l'examen clinique, vous constatez que cet œdème prend la cheville, le dos et les doigts des pieds, le signe de Stemmer est présent. Pas de turgescence jugulaire ni de reflux hépatojugulaire.



Causes du lymphoedème

- LO primaire:
 - Malformation des voies lymphatiques:
 - dysplasies, anaplasies, hypoplasies, ...
- LO secondaire:
 - Obstruction des voies lymphatiques secondaire à:
 - chirurgie et/ou radiothérapie, biopsie ggl., adénites, trauma.
 - obstruction par cellules malignes ou par la filariose

Epidémiologie

Lymphoedème primaire :

77% des cas

- congénital (< 2ans)
- précoce vers 25 ans (extrêmes 12-35 ans)
- tardif > 35 ans

Lymphoedème secondaire :

apparaît vers 50 ans

- tumeur : utérus (59%), prostate (15%)
- chirurgie + radiothérapie
- traumatisme (fracture du membre inférieur) (10%)

QCM 15

Cet état clinique traduit :

- ☒ A. Un lymphoedème secondaire
- ☐ B. Un lipoedème
- ☐ C. Un problème cardiaque
- ☐ D. Une insuffisance veineuse chronique
- ☐ E. Un lymphoedème primaire

QCM 16 (type A = 1 réponse)

Une femme de 35 ans, tabagique et obèse (BMI 30) avec fracture malléolaire au pied droit, plâtrée, développe une thrombose veineuse profonde proximale 15 jours plus tard.

Quelle est votre attitude parmi les propositions suivantes?

- A. Contrôle ultrasonographique dans 1 semaine
- B. Hospitalisation pour mise en route d'un traitement anticoagulant
- ☒ C. Mise en route d'un traitement par anticoagulant oral direct
- D. Suivi des D-dimères dans le temps
- E. Anticoagulation pour une durée minimale de 6 mois

QCM 17

Homme de 62 ans, ex fumeur, maçon, connu pour un pontage fémoro-poplitée gauche confectionné il y a 8 ans pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs de stade III, a été hospitalisé pour un infarctus du myocarde un mois auparavant et consulte pour l'apparition récente (environ une semaine) d'une plaie au gros orteil gauche associée à des douleurs type crampes à la marche.

Quelle peut être la cause la plus probable de cette nécrose ?

- A. Maladie professionnelle
- B. Connectivite
- C. Syndrome des anticorps antiphospholipides
- ☒ D. Embolisation artérielle
- E. Mal perforant

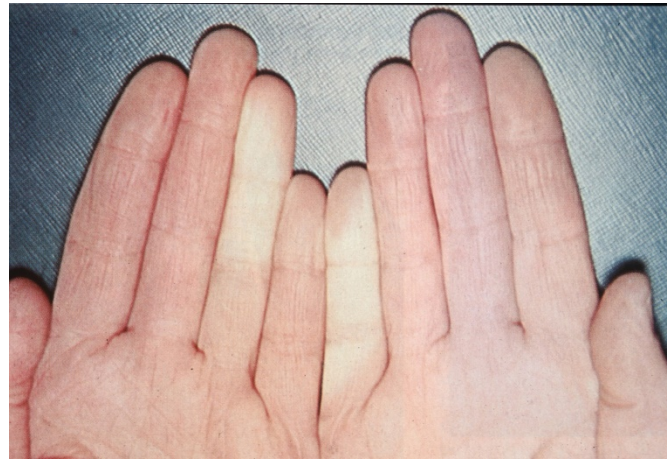
- Phénomène thrombo-embolique avec thrombus à partir:
 - du coeur (**fibrillation auriculaire**, anévrisme cardiaque, ...)
 - d'une artère en amont (**anévrisme**, thrombus sur plaque, fragment de plaque)
 - des veines, à condition qu'il y ait une communication D vers G
 - au niveau du coeur (p.ex. foramen ovale perméable) avec gradient (transitoire) de pression inversé ($D > G$)
 - au niveau des gros vaisseaux (fistule artério-veineuse de gros calibre)
- Thrombose locale
 - thrombose sur plaque, sur kyste poplité, sur piège artériel (pincement de l'artère par les muscles)
 - thrombose d'un **anévrisme**
 - thrombose sur vasculite ou due à une coagulopathie
 - thrombose d'un **pontage**
- Dissection
 - avec compression de la vraie lumière par la fausse
 - avec thrombose de la vraie lumière
- Traumatisme
 - rupture complète de l'artère
 - rupture partielle de la paroi artérielle avec dissection ou thrombose

QCM 18 (A = 1 réponse)

- Quelle combinaison de facteurs correspond au facteurs Vit K-dépendent ?
 - A. Facteurs V, VIII, XI, XIII
 - ☒ B. Facteurs IX, X, II, VII
 - C. Protéine C, Protéine S, Facteurs II et V
 - D. Facteurs V, II, VIII, XII

QCM 19 K' : une/plusieurs réponses corrects

Une fille de 17 ans, en BSH, 54 Kg/165cm, vous consulte pour une angine. Au cours de l'anamnèse, vous découvrez fortuitement qu'elle présente parfois une pâleur des doigts et vous montre une photo de ses mains sur son smartphone:



Quelle est votre attitude :

- ☒ A. Vous recherchez les facteurs déclenchant ou aggravants
- ☐ B. Vous demandez une capillaroscopie péri-unguéale
- ☐ C. Vous recherchez les facteurs antinucléaires
- ☒ D. Vous conseillez les mesures préventives
- ☒ E. Vous l'interrogez sur son orientation professionnelle

Causes du Phénomène de Raynaud

Etiologies	Femmes %RP	Hommes %RP
Raynaud primaire	84.0	43.0
Sclérodermie	2.4	-
Autre Connectivite	3.3	-
Sd des Vibrations	0.8	25.0
Sd du Marteau Hypothénar	-	18.0

Facteurs aggravants:

- Sd du Canal Carpien, Sd du Défilé Thoraco-Brachial
- Hypothyroïdie, B-bloquants, Ergotamine

Investigations / traitement ?

- Dans 85% cas, la clinique et l'interrogatoire suffisent
- Recherche des facteurs aggravants ou déclenchants
- Examens complémentaires:
 - AAN, capillaroscopie périunguéeale
- Traitement médicamenteux n'est rarement nécessaire pour les acrosyndromes

QCM 20 (K')

Homme de 69 ans, tabagique, diabétique, depuis 3 mois ressent des douleurs à la cuisse et au mollet à droite, qui apparaissent après environ 300 mètres de marche, et qui disparaissent après une période de repos d'environ 4 minutes.

Status: pouls périphériques présents, pas de gradient thermique, pas de discoloration cutanée

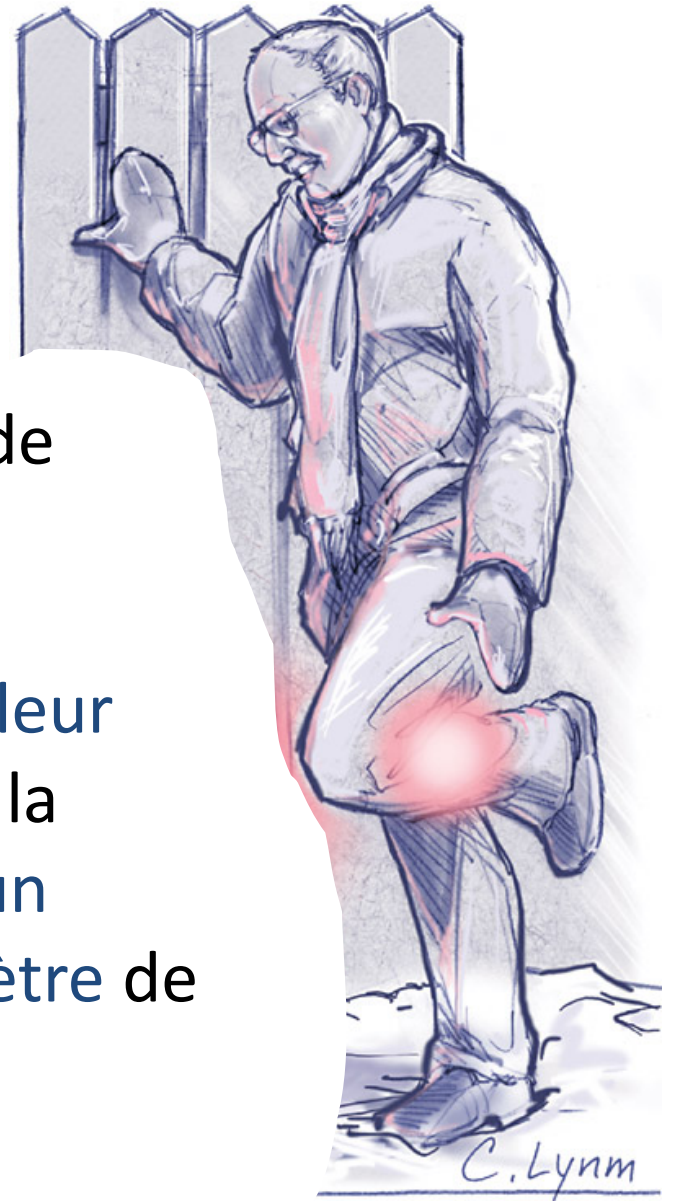
Doppler artériel: Ankle brachial index (ABI) = 0,74 au membre inférieur droit.

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) ?

- A. Vasculite
- B. Canal lombaire étroit
- ☒ C. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) stade II
- D. Problème orthopédique de hanche

Claudication

- Vient du latin *claudicatio* «action de boiter»
- Sensation de **fatigue** et/ou de **douleur** d'un membre après un effort ou à la station debout qui survient **après un certain temps** ou un **certain périmètre** de marche fixe



QCM 21 (K')

Homme de 53 ans, tabagique et hypertendu, dont le père vient de décéder d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) se présente à votre consultation pour un dépistage vasculaire.

Que faites-vous ?

- ☒ A. Recherche d'anévrisme artériel
- ☒ B. Mesure de l'ankle brachial index (ABI)
- ☒ C. Recherche de facteurs de risques cardiovasculaires
- D. Dosage D-dimères
- E. Réalisation d'une IRM cardiaque

QCM 22 (K')

Une patiente obèse de 68 ans, en bon état général, consulte pour un ulcère depuis 8 mois, suite à un traumatisme, au membre inférieur D s'aggravant progressivement. Actuellement, elle n'a aucun traitement en cours.

Dans ses ATCD, thrombose veineuse profonde du MID, ménisectomie G en 2004.

Au status: Varices du MID avec oedème distal, les pouls périphériques sont palpables ddc.

L'ulcération, localisée en périmalléolaire interne D, est peu douloureuse, superficielle et de grand diamètre avec un fond fibrineux et pourtour érythémateux.

L'absence de cicatrisation de cette ulcération est secondaire à:

A. Une atteinte artérielle des membres inférieurs

☒ B. un syndrome post-thrombotique du membre inférieur droit

C. une cancérisation de la lésion

D. une infection par pyocyaniques

☒ E. l'absence de traitement compressif

Question 23 K'

Patient turque de 30 ans, mécanicien, en bon état général, présente une nécrose de la pulpe du grand orteil depuis une semaine avec douleur plantaire.

Parmi les facteurs de risque cardiovasculaires, on retrouve un tabagisme important actif. L'examen clinique cardiovasculaire révèle une veine grande saphène gauche variqueuse et l'absence de pouls artériels pédieux ddc et tibial postérieur G. Aux membres supérieurs, la manoeuvre d'Allen est normal.

Les examens de laboratoire sont dans la norme.

Quelle affection peut donner lieu à un tel tableau clinique?

- ☒ A. Artériopathie oblitérante athéromateuse
- ☐ B. Ischémie aiguë sur embolisation
- ☐ C. Une maladie de Takayasu
- ☒ D. Une maladie de Buerger
- ☐ E. Un problème orthopédique du pied

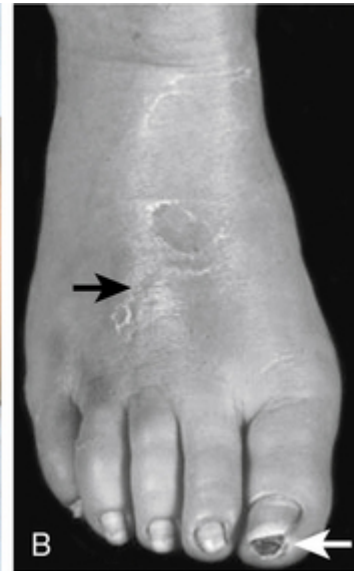
Maladie de Buerger (thromboangéite oblitérante)

- Maladie inflammatoire touchant des artères et veines de calibres **petits à moyens** et des nerfs des membres inférieurs et/ou supérieurs. Une atteinte distale est typique, avec ensuite une progression proximale
- Cause inconnue, mais forte association au tabac (bidis en Inde)
- Différences importantes aux autres vasculites:
 - thrombus inflammatoire avec parois peu affectées
 - ANA, facteur rhumatoïde, cryoglobulines, complément, complexes immuns négatifs
- N'apparaît jamais chez des non fumeurs et après 50 ans
- Prévalence (en % des patients présentant une artérite)
 - Europe occidentale 0.5 - 5.6
 - Inde 45



Maladie de Buerger: tableau clinique

- Homme tabagique < 40 – 45 ans
- Claudication distale (pieds>jambes, mains>bras)
- Lésions ischémiques (nécroses) des orteils ou des doigts accompagnées de violentes douleurs
- Thrombose (peut être migrante) superficielle dans 40% des cas
- Phénomène de Raynaud chez 40% des cas
- Atteinte (avec ou sans expression clinique)



Question 24 K'

Femme de 66 ans, tabagique et hypertendue présente des télangiectasies au membre inférieur gauche. Elle se plaint d'une sensation de lourdeur des jambes en fin journée et décrit un périmètre de marche illimité. Elle est donc adressée par son médecin traitant pour un bilan vasculaire.

Status: pouls périphériques présents, télangiectasies péri malléolaires et cuisse droite.

Bilan vasculaire: ultrasonographie veineuse sans particularité. L'examen Doppler des membres inférieurs montre un Ankle brachial index (ABI) = 0,85 au membre inférieur droit et de 1.05 au membre inférieur gauche.

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) ?

- A. Claudication intermittente
- B. Canal lombaire étroit
- ☒ C. Artériopathie oblitérante stade I selon Fontaine
- ☒ D. Maladie veineuse chronique



Question 25

- Une femme de 78 ans consulte son médecin traitant pour des céphalées bitemporales et baisse de l'état général depuis 4 semaines. Lesquelles des éléments cliniques suivants vous paraissent suspects qu'il ne faut pas banaliser ces céphalées ?
- A) Un état dépressif
- ☒ B) Une claudication de la mâchoire
- ☒ C) Vitesse de sédimentation > 40 mm/h
- ☒ D) Trouble visuel monoculaire transitoire
- E) antécédents de migraine

Artérite «temporale» de Horton

giant cell arteritis

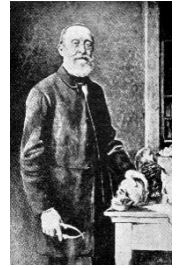
- La vasculite la plus fréquente (♀ 1 %/ ♂ 0.5 %)
- Vasculite des grands vaisseaux (branches de l'arc aortique et de l'aorte)
- Risque de cécité / séquelles 15-20 %
- Patients > 50 ans (♀: ♂ = 3:1)
- Symptômes généraux: EF, perte de poids, asthénie
- Aorte: aneurysmes/dissections/aortite



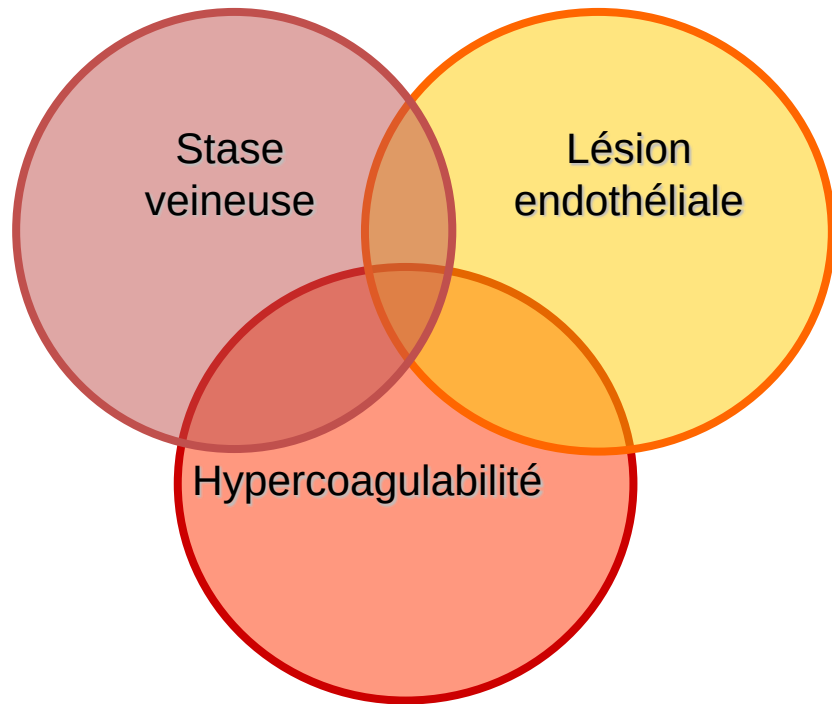
TVP-EP: diagnostic

L'examen clinique à lui seul ne permet pas de poser le diagnostic de TVP-EP toutefois, l'examen clinique et l'anamnèse jouent un rôle dans la détermination de la **probabilité clinique**

MTEV: Facteurs de risque



Triade de Virchow



Hypercoagulabilité

Thrombophilies héréditaires et acquises (i.e. contraception orale, néoplasie, grossesse, etc)

Stase veineuse

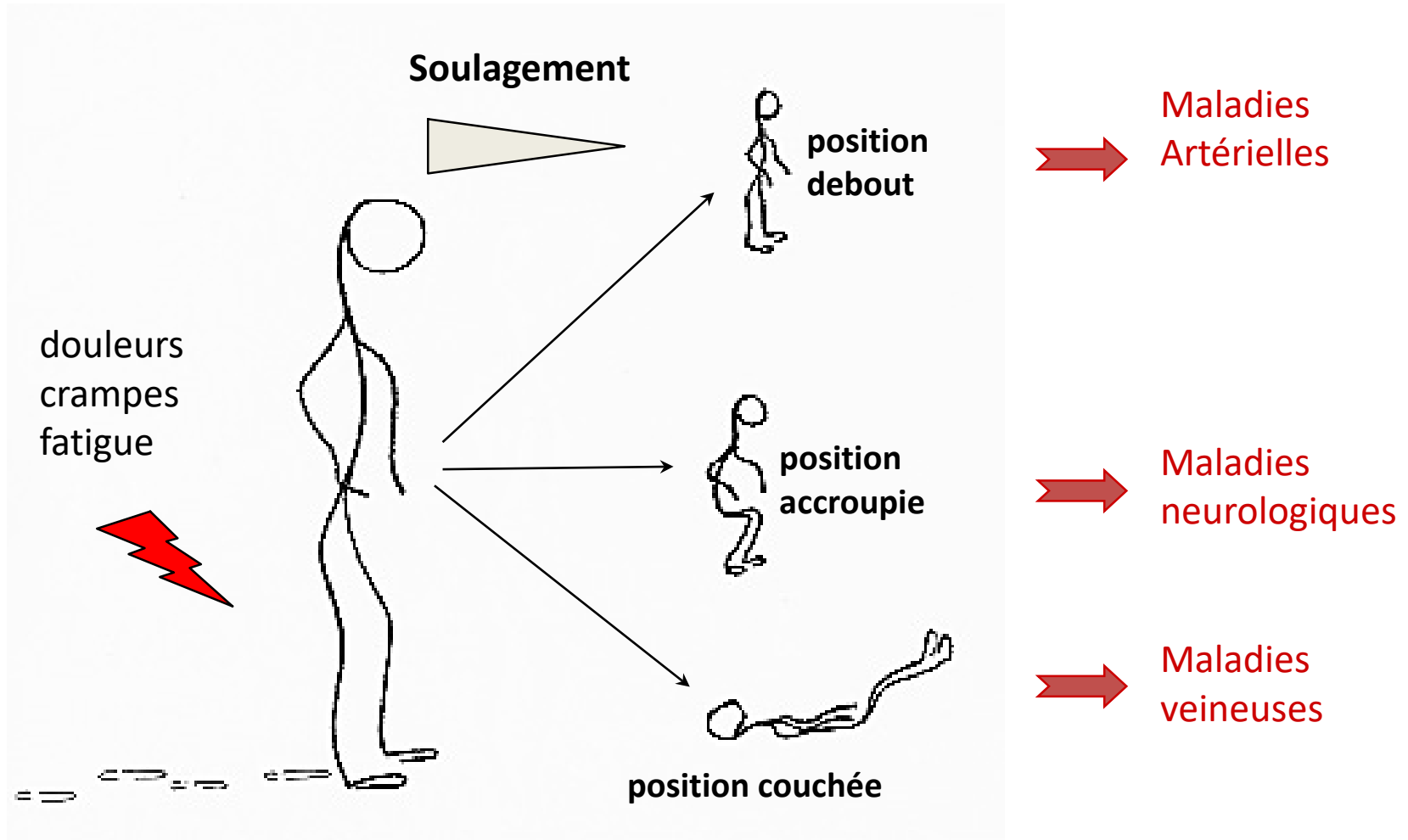
Immobilité, obésité, grossesse, compression, plâtre, etc.

Lésion endothéliale

Traumatismes, chirurgie, etc.

~ 40% des TVP-EP sont idiopathiques

Claudication



Autres DD : ostéoarthrite de hanche, syndrome de loges ...

Sémiologie vasculaire

Stade selon Fontaine (I-IV)

- I. Infraclinique; abolition d'un pouls distal
- II. Claudication intermittente/impuissance à l'effort
- III. Douleur au repos (nocturne)
- IV. Ulcère/nécrose ischémique

Examen clinique

L'examen doit se faire en position **debout**

Infiltration diffuse du derme et de l'hypoderme :

- plis cutanés transverses profonds à la racine des orteils et/ou aux malléoles
- aspect carré des orteils (**signe de Stemmer +**) traduit une participation lymphatique (lymphoedème pur ou oedème veino-lymphat.)
- aspect en poteau de la jambe
- disparition des reliefs malléolaires
- pyodermites végétantes (papillomatose +/- fistules lymphatiques)
 - ! surinfection (érysipèles)
 - ! angiosarcome (syndr. de Stewart-Treves): rare

Traitement du LO

- Drainages lymphatiques
- Bandages multicouches
- Bas de compression élastique

AAA-traitement

- Le traitement de l'AAA
 - dépend de sa taille (>5 cm)
 - de la vitesse de croissance
 - des symptômes
 - Compression
 - Douleurs abdominales, douleurs flancs, hydronéphrose, érosion vertébrale
 - Complications
 - Infection, embolisation, hématome mural, fistule entérique, coagulopathie

Quand dépister l'AOMI ?

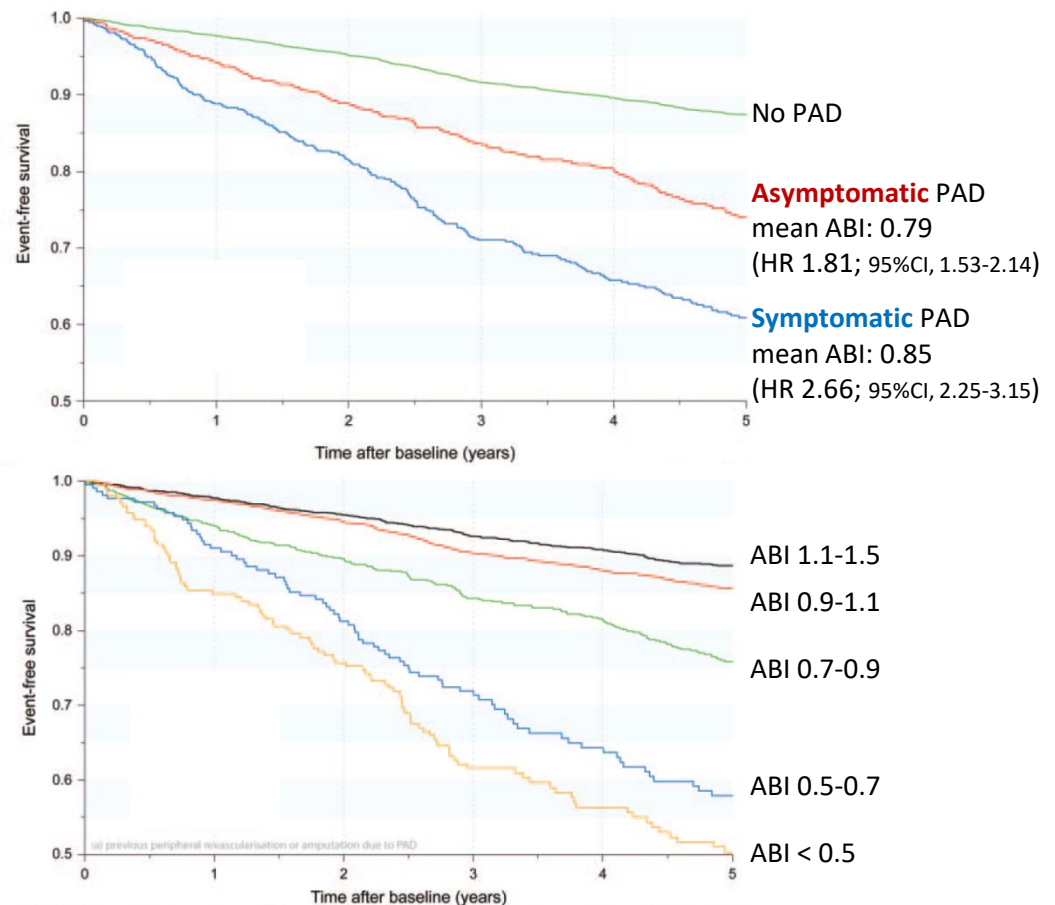
- Patients symptomatiques
- Patients asymptomatiques avec:
 - Diabète, surtout si depuis >10 ans et/ou facteurs de risque CV concomitants
 - Patients >65 ans
 - Patients ≥ 50 ans + facteurs de risque CV
 - Patients avec autres atteintes athérosclérotiques symptomatiques ou non

Un ABI pathologique prédit les événements cardiovasculaires

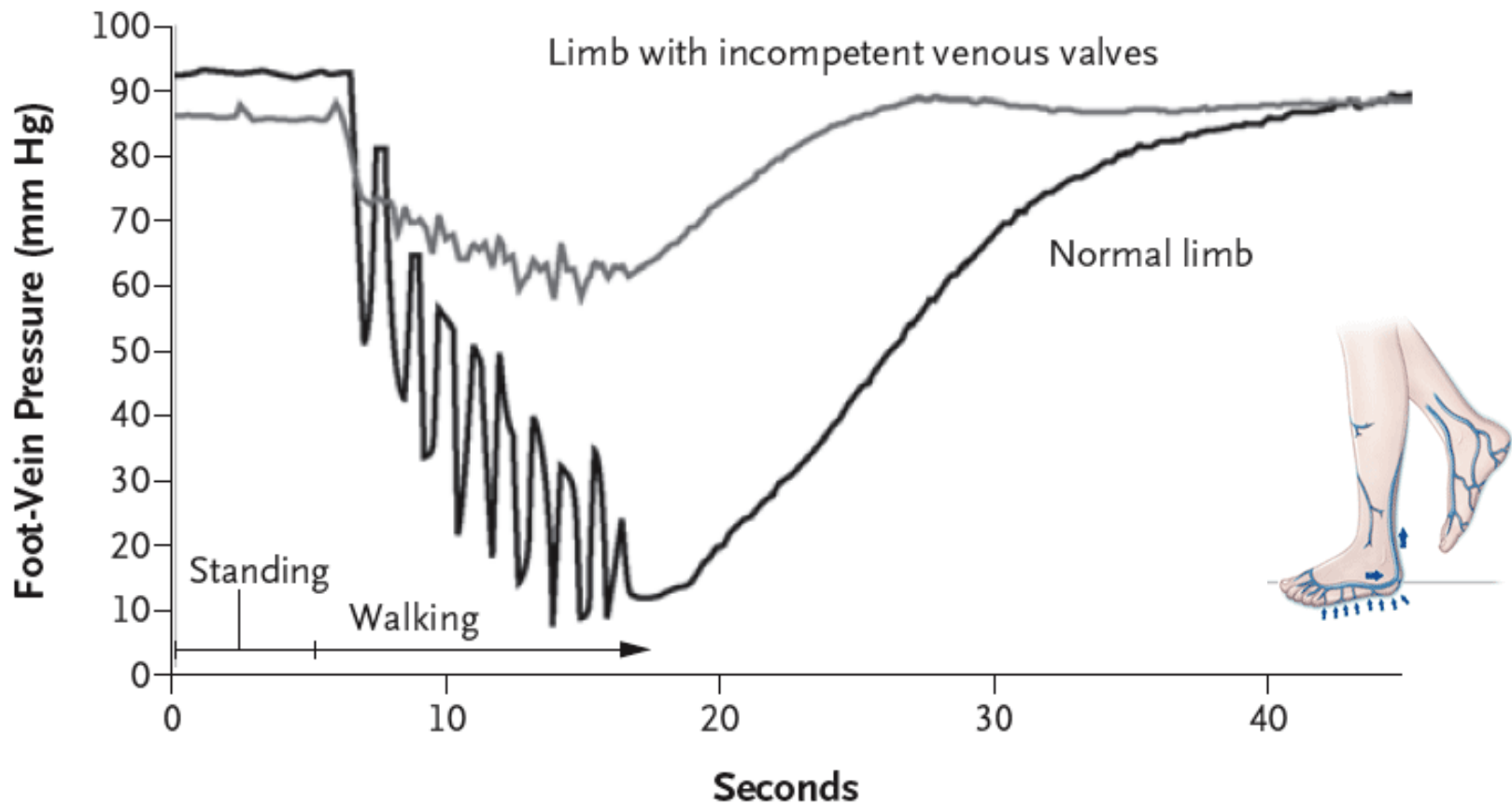
6880 pts:

- 12.3% AOMI asymptomatique
- 8.7% AOMI symptomatique

Event: severe vascular event (MI, coronary revascularization, stroke, carotid revascularization, peripheral revascularization, amputation)



Incontinence valvulaire



Types de QCM (questions à choix multiple)

- A une réponse parmi 5 est correct ou fausse
- B groupe de réponses pour plusieurs questions successives
(chaque fois, une ou plusieurs réponses sont justes)
- E Recherche d'un rapport causal entre deux propositions
- K' plusieurs réponses peuvent être correctes
- R